Comment la résilience post-Ebola en Guinée contribue à la gestion de la COVID-19 ?

Stéphanie Maltais, **Sophie Brière**, **Sanni Yaya**

Dans **Santé Publique** **2022/4 Vol. 34** , pages 557 à 567
Éditions **S.F.S.P.**

ISSN 0995-3914
DOI 10.3917/spub.224.0557
Date de mise en ligne : 28/12/2022

Article disponible en ligne à l'adresse
https://stm.cairn.info/revue-sante-publique-2022-4-page-557?lang=fr

CAIRN.INFO

Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.

Distribution électronique Cairn.info pour S.F.S.P..
Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.
Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

Recherche originale

Comment la résilience post-Ebola en Guinée contribue à la gestion de la COVID-19 ?

How the post-Ebola resilience in Guinea helps to manage COVID-19?

Stéphanie Maltais[1,2], Sophie Brière[3], Sanni Yaya[1,4]

S.F. Sophie Brière 5/10/2026 sur https://stm.cairn.info (IP: 165.51.9.5)

Résumé

Introduction : Le cas d'Ebola en Guinée (2013-2016) a été révélateur de faiblesses en matière de résilience du système de santé. Il a également permis de prendre la mesure d'un défi : pouvoir coordonner tous les acteurs de la réponse. Après l'épidémie, les autorités nationales et leurs partenaires internationaux ont amorcé un travail pour renforcer le système de santé. En 2021, la Guinée a fait face à la COVID-19 simultanément à la résurgence d'Ebola et d'autres maladies à potentiel épidémique.

But de l'étude : L'objectif de cet article est d'analyser l'évolution des cinq caractéristiques de la résilience sanitaire de Kruk *et al.* dans le contexte guinéen. Pour ce faire, une triangulation des données a été effectuée grâce à une revue de littérature, 41 entretiens semi-dirigés avec des parties prenantes internationales, nationales et locales, et 37 événements observés dans la période post-Ebola.

Résultats : Nos résultats montrent que la caractéristique de l'intégration a été la plus importante dans notre étude, grâce au renforcement de la coordination, de la communication et du partage d'informations entre les parties prenantes lors des crises. Ensuite, la diversité expose la nécessité de pouvoir faire face à plusieurs défis sanitaires en simultané. Les efforts avaient été concentrés sur Ebola pendant la première épidémie, mais depuis la pandémie de COVID-19, l'État est en mesure de faire face à plusieurs défis sanitaires. La conscience, quant à elle, suppose le besoin de connaître le contexte, ses forces et faiblesses. La Guinée a tiré les leçons d'Ebola et a mis en œuvre un programme de renforcement du système de réponse aux épidémies post-Ebola. Concernant l'autorégulation, le pays est désormais doté en ressources et possède des mécanismes de remontage de l'information et d'intervention qui ont fait leurs preuves. Enfin, l'adaptabilité constante en tenant compte des leçons apprises permet de rectifier le tir et de se préparer à d'autres crises potentielles et c'est ce qui est continuellement fait.

Conclusions : Étant donné la fragilité ubiquiste de la Guinée, le système de santé n'est toujours pas pleinement résilient. Toutefois, les gains dans chacune des caractéristiques de la résilience améliorent certainement la riposte face à la COVID-19.

Mots-clés : Résilience ; Systèmes de santé ; Guinée ; Ebola ; COVID-19.

Abstract

Introduction: *The case of Ebola in Guinea (2013-2016) revealed weaknesses in the resilience of the health system and highlighted the challenge of coordinating all actors in the response. After the epidemic, national authorities and their international partners began to strengthen the health system. In 2021, Guinea faced COVID-19 simultaneously with the resurgence of Ebola and other diseases with epidemic potential.*

Purpose of research: *The objective of this article is to analyze the evolution of the five characteristics of health resilience of Kruk et al. (2015) in the Guinean context. To do this, data triangulation was carried out through a literature review, 41 semi-structured interviews with international, national and local stakeholders, and 37 events observed in the post-Ebola period.*

Results: *Our results show that the characteristic of integration was the most important in our study. This is because of the importance of coordination, communication and information sharing among stakeholders during crises. Then, diversity exposes the need to be able to face several health challenges simultaneously. Efforts were focused on Ebola during the first outbreak, but since the COVID-19 pandemic, Guinea has been able to cope with several health challenges. Raising awareness, on the other hand, necessitates an understanding of the context, its strengths, and weaknesses. Guinea learned lessons from Ebola and implemented a program to strengthen the emergency response system. On self-regulation, the speed of the response relies on mechanisms for early detection, notification, and response. The country is now well resourced and has proven information and response mechanisms. Finally, constant adaptability by taking into account lessons learned allows us to set course and prepare for other potential crises and this is what is being done constantly.*

Conclusions: *Given Guinea's ubiquitous fragility before Ebola, the health system is still not fully resilient. However, gains in each of the characteristics of resilience improve the response to COVID-19.*

Keywords: *Resilience; Health System Strengthening; Guinea; Ebola; COVID-19.*

[1] École de développement international et mondialisation – Université d'Ottawa – Canada.
[2] Faculté de gouvernance, des sciences économiques et sociales, Université Mohammed VI Polytechnique – Rabat – Maroc.
[3] Université Laval – Québec – Canada.
[4] The George Institute for Global Health – Imperial College – Londres – Royaume-Uni.

Correspondance : S. Maltais
smalt006@uottawa.ca

Réception : 03/01/2022 – *Acceptation :* 19/04/2022

S.P. | Téléchargé le 15/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 165.51.95.220)

Introduction

La pandémie de COVID-19 met à l'épreuve la résilience des systèmes de santé à l'échelle planétaire, incluant des systèmes bien dotés en ressources, notamment en Amérique du Nord et en Europe [1]. Dans plusieurs États fragiles, cette résilience a été défiée à maintes reprises, comme ce fut le cas en Guinée pendant l'épidémie de maladie à virus Ebola qui a sévi entre décembre 2013 et juin 2016. Même si les épidémies affectent tous les pays du monde, leur impact est généralement plus grand sur les États fragiles en raison de leur moindre résilience, qui s'explique par l'inefficacité des institutions ou encore des fondements économiques précaires [2]. Il faut toutefois reconnaître que les épidémies précédentes dans ces pays ont permis d'acquérir une expertise et de bons réflexes pour favoriser une meilleure gestion des épidémies [3, 4].

L'épidémie d'Ebola en Guinée a démontré de quelle manière des lacunes dans les conditions de base qui favorisent la résilience pouvaient se traduire par des difficultés dans la gestion et la coordination de la crise [5-7]. Par sa mortalité (elle a provoqué 2 544 décès dans le pays) [8], elle a été révélatrice de certaines insuffisances en matière de gouvernance, de qualification du personnel, de variété des ressources disponibles et de mobilisation des acteurs communautaires en vue d'améliorer la réponse sanitaire, qui viennent s'ajouter aux faiblesses du système de santé en matière de surveillance, d'information sanitaire et d'approvisionnement en médicaments [3, 5-7, 9].

Depuis 2016, les parties prenantes, internationales, nationales et locales impliquées dans la réponse aux crises sanitaires en Guinée travaillent pour améliorer la gestion des crises et clarifier le rôle de tous les acteurs impliqués afin de mieux coordonner les réponses [3]. Des améliorations dans tous les aspects de la gestion des crises sanitaires sont aujourd'hui visibles face à la COVID-19 et à d'autres maladies infectieuses qui surviennent en simultané [4]. À la date du 12 décembre 2021, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) rapportait sur son site internet 30 814 cas confirmés et 388 décès associés à la COVID-19.

Dans cet article, nous répondrons à la question suivante : comment la résilience développée depuis la première épidémie d'Ebola contribue-t-elle à la gestion de la COVID-19 ? Notre analyse s'appuie sur les cinq caractéristiques de la résilience sanitaire de Kruk *et al.* [7]. Les résultats sont issus de deux collectes distinctes, la première a été faite dans le cadre d'une thèse doctorale sur la gestion des crises sanitaires dans les États fragiles avec une étude de cas portant sur Ebola en Guinée [3] ; la seconde émane d'une revue de littérature sur la COVID-19 en Guinée. Notre étude permettra de mieux comprendre le contexte de la Guinée avant l'épidémie et ce qui a été mis en place depuis pour développer une gestion résiliente des crises sanitaires dans le pays.

Matériels et méthodes

La résilience des systèmes de santé

Il existe pléthore de définitions de la « résilience », mais celle-ci se résume en « la capacité d'une personne ou d'un système à se remettre d'un choc et à demeurer relativement stable dans un environnement turbulent » [10]. Dans le cadre de cette étude, nous retenons la définition de la résilience des systèmes de santé de Kruk *et al.* [7], soit la capacité des acteurs sanitaires, des institutions et des populations à se préparer et à répondre efficacement aux crises, à maintenir les fonctions essentielles lorsqu'elles surviennent, à apprendre d'elles et à s'adapter lorsque nécessaire.

Dans la réponse aux maladies à potentiel épidémique, la préparation prend une place prépondérante [11-13]. D'autres éléments peuvent favoriser une meilleure gestion des épidémies comme le leadership et la bonne gouvernance, les cadres législatifs, les structures, les mécanismes et les programmes de gestion et de coordination des urgences sanitaires [11].

Le fait de renforcer la résilience des systèmes de santé et de gestion des crises est un défi en raison du contexte particulier de fragilité de chaque État [14]. Les connaissances de la culture et des conditions socio-économiques, politiques et historiques des communautés affectées sont essentielles pour la lutte contre les épidémies dans les pays en développement [6, 15].

Il est intéressant d'observer la vulnérabilité du système de santé guinéen avant Ebola en 2013 pour la comparer à la résilience acquise depuis 2017. Pour ce faire, nous utiliserons le schème de résilience sanitaire présenté dans le tableau I.

Collecte et traitement des données

Afin de mieux saisir la résilience face aux crises sanitaires dans les États fragiles, le cas empirique d'Ebola en Guinée a été sélectionné. Des gestionnaires issus d'organisations internationales, nationales et locales, qui ont participé à la

S.F.S.P. | Téléchargé le 15/10/2022 sur https://stm.cairn.info (IP: 165.51.95.249)

Tableau I : Modèle de la résilience sanitaire adapté de Kruk *et al*. [7]

Conscience	Connaître les forces, la vulnérabilité, les risques, les stratégies d'intervention et planifier une réponse face à une possible perturbation du système.
Diversité	Faire face à une variété de défis sanitaires en offrant des soins de qualité, et en répondant à tous les besoins en tout temps.
Autorégulation	Cerner les menaces sanitaires et les isoler rapidement. Maintenir les services essentiels pendant les crises et mobiliser les ressources adéquatement.
Intégration	Partage d'information, communication et coordination entre une variété de parties prenantes multisectorielles.
Adaptabilité	Changer les façons de faire rapidement et apprendre de l'expérience pour s'améliorer continuellement.

gestion d'Ebola et au relèvement post-Ebola ont été rencontrés et observés entre avril et août 2017, *a posteriori* de la première épidémie d'Ebola, ce qui a permis de documenter les leçons apprises et la préparation aux futures crises. Leurs méthodes d'intervention par rapport aux variables de la résilience sanitaire de Kruk *et al.* [7] ont été analysées.

Comme la résilience ne peut être mesurée facilement grâce à des données quantitatives [15], une analyse qualitative a été privilégiée à travers trois méthodes de collecte de données :

- des entretiens semi-dirigés ;
- l'observation directe non participante ;
- l'analyse documentaire.

Tableau II : Provenance des gestionnaires rencontrés [3]

Acteurs internationaux	Nations unies	7
	Banque Mondiale	1
	Acteurs bilatéraux	2
	Organisations non gouvernementales (ONG)	6
	Réseau sous-régional	1
Acteurs nationaux	Ministère de la Santé	3
	Présidence	1
	Agence nationale de sécurité sanitaire et ancienne cellule nationale de lutte contre Ebola	9
	Autres (laboratoires, Institut national de santé publique, etc.)	4
Acteurs locaux	Direction préfectorale ou communale de la santé ; Direction de la santé de la ville de Conakry	5
	Autres (ONG, secteur privé)	2
TOTAL		41

En tout, 41 entretiens ont été réalisés d'une durée moyenne de cinquante-trois minutes. Le tableau II présente l'institution d'attache des gestionnaires et la taille de l'échantillon.

Une grille d'observation comprenant les éléments pertinents pour chacune des cinq caractéristiques de la résilience a été remplie lors de chacun des 37 événements observés (réunions d'information épidémiologique, visites de lieux, conférences, ateliers de renforcement de capacités et autres).

Cette collecte sur le terrain a été complétée par une analyse documentaire. En plus de la revue de littérature, certains documents nationaux, non disponibles publiquement ont été obtenus. Leur analyse a permis d'obtenir des données primaires, et de corroborer les informations en provenance des autres méthodes de collecte. Pour la COVID-19, une revue de littérature a été réalisée. Il a aussi été possible d'obtenir des données primaires et de contre-vérifier certaines informations auprès de personnes-ressources en Guinée.

Les données des entretiens (transcriptions intégrales), des observations (grilles d'observation) et des documents pertinents (documents complets) ont été codées et catégorisées dans QDA Miner selon différentes variables (tableau III).

S.F.S.P. | Téléchargé le 15/10/2026 sur https://stm.cairn.info (IP: 165.51.95.220)

Tableau III : Cadre d'analyse des données adapté de Kruk *et al.* et Ling *et al.* [3, 7, 36]

Catégories	Codes
Conscience	Crises vécues précédemment Enjeux de développement/fragilité/vulnérabilité/risques Cadres/guides de gestion de crise sanitaire
Diversité	Défis variés en santé Activités sanitaires régulières pendant Ebola Capacités et compétences Ressources
Autorégulation	Rapidité de détection des menaces, de notification et d'intervention Sécurité et suivi des contacts Forces dans la gestion de la crise Faiblesses et défis dans la gestion de la crise Gestion des réticences communautaires
Intégration	Coordination et relations entre les acteurs Leadership national Communication et partage d'informations Rôles et responsabilités des acteurs Méthodes de gestion ; mécanismes de prise de décision
Adaptabilité	Changements de façons de faire Leçons apprises Préparation à une autre crise potentielle Nouveaux outils développés et innovations Appropriation/Pérennité/Durabilité Capacité de gestion autonome d'une future crise sanitaire

Nous avons pu comparer l'occurrence des différents codes pour les trois méthodes de collecte et mettre en relation les phénomènes observés pour chacune d'elles. La triangulation des données a eu pour objectif de diminuer les biais possibles et les limites de chacune des méthodes de collecte de données.

Une grille d'analyse de la triangulation a été développée pour objectiver nos données qualitatives. À chacune des sources de données, un pointage a été accordé pour avoir discuté des caractéristiques de la résilience sanitaire. L'objectif était de voir quelles étaient les caractéristiques de la résilience sanitaire les plus représentées dans le cas étudié. Le tableau IV montre la somme des pointages pour chacune des caractéristiques de la résilience sanitaire.

Ce tableau montre que chacune des caractéristiques de la résilience a pu être analysée et que certaines ont été plus importantes que d'autres.

Tableau IV : Somme des pointages associés à chacune des caractéristiques de la résilience sanitaire [3]

Caractéristique de la résilience	Pondération des entretiens	Pondération de l'observation directe non participante	Pondération de l'analyse documentaire	Pointage total
Conscience	10	10	9	29
Diversité	14	8	9	31
Autorégulation	14	8	4	26
Intégration	16	6	13	35
Adaptabilité	14	6	5	25

Résultats

La caractéristique la plus documentée a été celle de l'intégration, ce qui se justifie par le grand nombre de données disponibles sur les rôles et responsabilités des acteurs impliqués et sur leur coordination.

© S.P. | Téléchargé le 15/12/2022 sur https://stm.cairn.info (IP: 165.51.95.249)

Intégration (35 points) : coordonner une multitude de parties prenantes

Structures et méthodes de gestion

Pendant l'épidémie d'Ebola, diverses méthodes de gestion et de coordination ont été adoptées. Au début, une cellule de crise interministérielle a été créée pour la gestion. Cependant, son aspect trop politique et pas assez opérationnel a soulevé certaines critiques, ce qui a poussé à la création de la Cellule nationale de lutte contre Ebola, composée de différentes unités spécialisées en surveillance, en communication, en logistique et autres. Un acteur national a déclaré : « *Très vite* […], *lorsqu'on met en place un comité interministériel avec des politiques, on n'a pas la même vision que les techniciens. Il y a une certaine lourdeur.* » Un autre a d'ailleurs rappelé que « *les urgences n'attendent pas l'administration* » et qu'il faut avoir une attitude de résolution de problème de santé publique parfois en dépit des procédures existantes.

Coordination et leadership

Les défis ont été nombreux en raison du grand nombre d'acteurs qui ont été amenés à travailler ensemble. Parmi les principaux soulignés, on peut citer : le manque de prise en compte des gestionnaires guinéens, le non-respect de la hiérarchie instaurée, des rôles et responsabilités de chacun, le manque d'encadrement, de coordination, d'harmonisation et de leadership en début de crise, les intérêts divergents des partenaires, les conflits de valeurs ou les standards différents, le nombre élevé d'acteurs, les réticences et méfiances des acteurs les uns avec les autres et la compétition entre acteurs impliqués.

Rôles et responsabilités

Au fur et à mesure que l'épidémie d'Ebola a évolué, la coordination s'est réellement mise en place, ce qui s'est traduit par une volonté de pérenniser la structure de la Cellule nationale de lutte contre Ebola en la transformant en ANSS. Rattachée au ministère de la Santé mais investie d'une plus grande autonomie de gestion, celle-ci est aujourd'hui responsable de la gestion de la COVID-19 et de toutes les autres maladies à potentiel épidémique. Au début de la pandémie, les mesures adoptées demeuraient désorganisées et manquaient de cohérence ce que Bonnet *et al.* [16] attribuent à la compétition entre l'ANSS et le ministère de la Santé.

Diversité (31 points) : capacité à affronter une variété de défis sanitaires

Défis variés en santé

Toute l'attention a été concentrée sur Ebola aux dépens des autres pathologies et des activités sanitaires régulières maintenues pendant cette période. Dans la période post-Ebola, les autres maladies sont revenues sur la sellette et ont continué à faire l'objet de suivi et de formation.

Ressources financières

Par ailleurs, des insuffisances sur le plan des ressources existaient avant Ebola, ce qui a nécessité un apport important de la part des partenaires. Plusieurs participants ont décrié la pauvreté du budget accordé à la santé avant Ebola et ses conséquences sur le développement du système sanitaire. Selon les données officielles obtenues auprès du ministère du Budget guinéen, une tendance à la hausse a toutefois pu être observée il y a quelques années, faisant passer sa part dans le produit industriel brut (PIB) de 3,1 % en 2015 à 5,2 % en 2017 et à 12,4 % en 2020. Les faibles investissements nationaux en santé durant l'épidémie d'Ebola ont fourni des arguments à de nombreux interlocuteurs rencontrés pour aborder la dépendance aux bailleurs de fonds. Cette dépendance se heurte à une instabilité du financement externe, à laquelle s'ajoutent la méfiance et le difficile décaissement de l'argent par les partenaires. La COVID-19 met en lumière cette instabilité du financement puisque les ressources des partenaires ont été beaucoup plus limitées que pendant Ebola [17].

Ressources matérielles, techniques, technologiques et logistiques

Du point de vue des autres ressources, la forte majorité des répondants a évoqué le fait que la Guinée ne possédait pas les ressources matérielles, techniques, technologiques ou logistiques pour gérer une épidémie comme Ebola. Les centres de santé étaient en nombre insuffisant et n'étaient pas équipés pour gérer une maladie émergente. Il existait un laboratoire des fièvres hémorragiques, mais qui ne pouvait diagnostiquer le virus d'Ebola. Ce manque a dû être pallié par neuf laboratoires étrangers qui sont venus avec leur matériel pendant l'épidémie. Certains répondants ont aussi cité en exemple le manque de structures adéquates d'isolement dans les centres de santé et hôpitaux. Depuis, des centres de traitement des maladies à potentiel épidémique, communément appelés « CT-EPI », ont été construits dans chaque préfecture. L'ensemble des structures de

(c) S.P. | Téléchargé le 1/12/20 sur http://sante-publique.cairn.info (IP: 165.51.95.220)

riposte mises en place au temps d'Ebola sont restées en place, mais les capacités demeurent limitées comme en témoignent la capacité d'hospitalisation dépassée à l'hôpital Donka ou encore le fait qu'un seul laboratoire pratiquait la PCR en début de pandémie [18].

Ressources humaines

Au sujet des ressources humaines, huit personnes interrogées ont parlé de l'insuffisance de personnel au sein des structures de santé avant Ebola et du manque de couverture pour l'ensemble du pays. Mais la Cellule nationale de lutte contre Ebola a permis l'embauche de 800 jeunes. Puis, en 2016, le gouvernement a embauché 4 000 personnes et s'est engagé à en recruter 2 000 de plus chaque année jusqu'en 2020. Pour contrer le manque de représentativité à l'échelle du pays, le ministère de la Santé a également mis en place une Commission nationale de mutation du personnel. Face à la COVID-19, les ressources humaines démontrent une expérience acquise en matière de connaissances, attitudes et pratiques de prévention et de contrôle des infections [19], mais il n'est pas possible de redéployer les mécanismes de surveillance qui étaient en place pendant la première épidémie d'Ebola en raison d'un appui international moins important que pendant Ebola [20].

Conscience (29 points) : bien connaître le contexte

Crises vécues précédemment

Lors de nos entretiens, quelques personnes ont abordé les risques et la fragilité du système sanitaires avant Ebola. Questionnés sur les précédentes crises sanitaires en Guinée, huit répondants ont reconnu la dépendance aux partenaires internationaux lors de celles-ci. À titre d'exemple, une personne a mentionné la présence de Médecins sans frontières sur le territoire depuis une trentaine d'années, même si le pays n'est pas en crise humanitaire continue.

Connaissance du contexte

Au sujet de la COVID-19, Delamou *et al.* [17] rappellent l'importance de bien connaître le contexte social et économique puisqu'il peut informer sur les actions à prendre. Par exemple, les réticences des populations envers les pouvoirs publics actuellement, liées au contexte politique, peuvent se traduire par une faible fréquentation des structures de santé [18].

Présence de plans, cadres et guides de gestion des crises sanitaires

Par ailleurs, plusieurs participants ont reconnu l'absence de plans de contingence et de réponse d'urgence avant Ebola pour permettre de planifier la riposte, avec des répercussions directes sur la promptitude de la réponse. Selon un acteur international, il n'y avait « *pas de visibilité sur qui fait quoi, quand et où, que ce soit le ministère de la Santé, les agences des Nations unies, ainsi que les ONG nationales et internationales. Qui active le plan, quand ? Les différentes phases d'intervention n'ont pas été définies par catastrophe, ou même pour les autres urgences épidémiques* ». Ce n'est que dans le relèvement post-crise qu'un réel travail de fond a été entamé pour la rédaction de plans opérationnels et stratégiques, comme le Guide technique de surveillance active en ceinture ou encore le Guide des équipes régionales polyvalentes d'alerte et de riposte aux épidémies.

Cartographie des acteurs

Pendant la crise, une cartographie des acteurs a été réalisée. Malgré cela, Delamou *et al.* [17] ont rapporté l'ambiguïté persistante dans le rôle des parties prenantes dans la gestion de la COVID-19. Par exemple, le décret présidentiel désigne l'ANSS comme organe de coordination de la riposte au détriment du ministère de la Santé.

Autorégulation (26 points) : stabiliser le système face aux menaces

Forces dans la gestion de la crise

Parmi les forces de la gestion de la crise Ebola, on peut notamment soulever : l'implication effective des partenaires internationaux, la mise en place de structures de gestion de crise décentralisées, la mise en place d'équipes de réponse rapide multidisciplinaires, le développement de directives formelles pour la prise de décision, le diagnostic et la prise en charge. À l'échelle nationale, ont surtout été reconnus la mobilisation efficace des moyens et de la logistique, la surveillance efficace, le déploiement rapide de laboratoires mobiles soutenu par les partenaires internationaux et le suivi rapide des contacts qui a permis de maîtriser rapidement les foyers d'éclosion.

Faiblesses dans la gestion de la crise

Un acteur national a aussi rapporté plusieurs lacunes, dont la faible implication des femmes dans la riposte, le

S.F.S.P. | Téléchargé le 17/12/25 sur https://www.cairn.info (IP: 165.51.95.249)

retard de l'implication des leaders communautaires, la lenteur des laboratoires pour les tests, celle des agents de la Croix-Rouge pour organiser des enterrements dignes et sécurisés, la mauvaise communication au début, la réticence au sein des communautés et la mauvaise coordination des activités des partenaires. Malgré cela, l'expérience acquise a fait que les menaces ont pu être cernées et isolées de plus en plus rapidement. Des stratégies de quarantaine ont été adaptées et des socioanthropologues ont été impliqués pour éviter les réticences communautaires.

Rapidité de détection, de notification des menaces et d'intervention

Dans le cas de la COVID-19, la Guinée a rapidement mis en place, en mars 2020, des mesures de surveillance et de riposte comme le contrôle des voyageurs à l'aéroport, l'instauration d'un couvre-feu, la déclaration de l'état d'urgence, etc. [16]. Par contre, il persiste une faible capacité à tester pour la COVID-19 et on remarque aussi que la désinformation *via* les médias publics et les réseaux sociaux est toujours présente, ce qui requiert davantage d'investissements dans la sensibilisation communautaire [20].

Adaptabilité (25 points) : tirer des leçons pour accroître la résilience

Changements dans les façons de faire et acquis

La principale amélioration notée pour faciliter la transition vers la résilience est la formation et le renforcement des capacités des ressources humaines. Viennent ensuite les acquis en termes de matériels et de technologies et l'amélioration de la surveillance et de la notification des cas suspects sont des avancées. Dans une moindre mesure, d'autres éléments ont été répertoriés, dont le développement de la santé à base communautaire, la rédaction de plans et l'actualisation des procédures, le recrutement de personnel et son déploiement à l'échelle du pays et la création de nouvelles équipes d'intervention rapide.

Appropriation nationale de la gestion de la crise

L'adaptabilité passe aussi par l'appropriation de la gestion des crises. Selon un acteur international, il persiste une dangereuse dépendance aux partenaires techniques et financiers dans la prise de grandes décisions. Pendant la pandémie de COVID-19, la riposte est toujours assurée par un appui considérable de partenaires internationaux dont Médecins sans frontières (MSF), Alima, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'UNICEF [17]. On peut tout de même noter une affirmation du leadership guinéen depuis Ebola reconnue par 16 personnes lors de nos entretiens, mais aussi le fait que ce leadership a été assumé principalement par une seule personne. Selon un acteur international :

> *« La mise en place de la structure de coordination pendant la riposte, l'application par la coordination des meilleures stratégies, la recherche des justes mesures pour coordonner différentes approches et partenaires, témoignent en faveur de ce leadership réussi. La preuve est le contrôle de l'épidémie. Mais le point négatif était simplement le temps plus ou moins long pour l'assumer. »*

Malgré les leçons apprises, sans une implication franche des acteurs guinéens, une appropriation réelle des réponses et la décentralisation de la réponse à l'échelle locale, plusieurs acteurs rencontrés sont sceptiques quant à la possibilité de devenir réellement résilient. Comme affirmé par un acteur local :

> *« La communauté n'était pas impliquée dans la lutte contre les maladies. Mais, avec Ebola, il y a des organisations qui ont été mises en place dans tous les quartiers du pays […]. Il y avait des individus, des chefs religieux ou des chefs de quartiers, des responsables des jeunes, des femmes, qui ont été mobilisés et chargés, au même titre que nous, de faire la surveillance. »*

Face à la COVID-19, Sow et Criel [18] dénoncent la gestion toujours très centralisée de la crise, malgré l'implication de nombreux agents de santé, mais aussi avec l'appui des autorités locales à l'échelle du pays.

Récapitulatif des acquis en termes de résilience en Guinée

Le tableau V présente un résumé des principaux acquis en matière de résilience pour chacune des périodes étudiées.

Discussion

L'objectif de cet article était d'analyser comment la résilience développée depuis la première épidémie d'Ebola pouvait contribuer à améliorer la gestion de la COVID-19. Cet article peut enrichir les discussions sur la pratique d'une gestion des crises sanitaires plus résiliente dans les États fragiles. Contrairement à ce que Delamou *et al.* [17]

S.P.S.S. | Téléchargé le 15/10/2026 sur http://www.cairn.info (IP: 165.51.95.220)

Tableau V : Analyse de la résilience sanitaire en Guinée par période adapté de [3]

Caractéristique de la résilience	Avant Ebola (2013)	Après Ebola (2017)	COVID-19 (2020-2021)
Intégration	Méconnaissance des rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans la gestion des crises sanitaires et coordination difficile	Cartographie des acteurs réalisée et travail effectué pour le renforcement de la coordination	Ambiguïté persistante sur les rôles et responsabilités des acteurs malgré les mécanismes de coordination existants
	Absence d'une structure de coordination des crises sanitaires efficace et dotée en ressources	Création de l'ANSS, mais dépendance aux partenaires techniques et financiers pour son fonctionnement	ANSS fonctionnelle et responsable de la riposte, mais toujours dépendante des partenaires internationaux
	Faible communication sur les risques et entre les organisations	Développement de mécanismes de communication et de remontage de l'information	Mécanismes de remontage d'information informatisé
Diversité	Incapacité à faire face à une variété de défis en santé	Reconnaissance de l'importance d'un plus grand nombre de maladies prioritaires à surveiller	Capacité à gérer des crises en simultanée
	Maigres investissements nationaux pour la santé (2,4 % du PIB en 2014)	Légère augmentation du budget national accordé à la santé (5,5 % du PIB en 2016)	Augmentation significative du budget national à la santé (12,4 % en 2020)
	Dépendance aux partenaires internationaux dans les domaines techniques et financiers	Persistance de la dépendance aux partenaires internationaux dans toutes les sphères de la riposte	Omniprésence des partenaires internationaux dans la surveillance et le traitement
	Ressources humaines, techniques, matérielles et logistiques insuffisantes en quantité et en qualité	Dotation en ressources de toutes sortes Accroissement et formation des ressources humaines Rénovation des structures sanitaires	Ressources disponibles, mais support important des partenaires internationaux
Conscience	Absence et insuffisance de cadres, guides et protocoles de gestion des crises sanitaires	Rédaction et validation en cours de nombreux plans, guides et protocoles de gestion des crises sanitaires	Divers plans existants
	Faiblesse du système de santé en général	Accroissement des capacités du système de santé en général	Accroissement des capacités du système en général
Autorégulation	Délai dans la notification et la réponse aux crises	Diminution du délai de notification des cas suspects de maladie	Promptitude dans les réponses aux crises, mais persistance d'un délai de notification
	Absence de structures et d'équipes de gestion des crises sanitaires au niveau central et décentralisé	Mise en place de structures et d'équipes de gestion des crises sanitaires aux diverses échelles	Équipes et structures décentralisées existantes
	Manque de connaissances et de procédures pour la surveillance et le suivi des contacts potentiellement infectés	Développement d'approches novatrices pour la surveillance, le suivi des contacts et le microcerclage	Utilisation et adaptation des stratégies existantes
Adaptabilité	Manque d'appropriation guinéenne lors des crises	Augmentation du leadership national, mais reposant sur quelques personnes	Leadership assuré par une poignée de personnes
	Balbutiements d'une approche de santé à base communautaire à partir de 2013 dans quelques préfectures	Développement de la santé à base communautaire à plus grande échelle	Implication des communautés dans la réponse

affirment, à savoir le fait que le pays n'a pas su conserver son expertise post-Ebola, nos résultats montrent plutôt que la première crise d'Ebola a eu des effets structurants, puisqu'elle a permis au pays de se remettre en question et de développer de nouvelles politiques et pratiques d'intervention qui renforcent le degré de résilience. Ce dernier varie d'une caractéristique à l'autre.

L'étude souligne l'importance de l'*intégration* et conséquemment l'aspect primordial que revêt la coordination des parties prenantes lors des crises sanitaires. Encore aujourd'hui, la compétition entre l'ANSS et le ministère de la Santé perdure puisqu'il n'y a pas de distinction claire entre les mandats de chaque entité. L'ANSS avait complètement absorbé les capacités de la Division de prévention et

© S.F.-SP. | Téléchargé le 17/12/2025 sur https://cairn.info (IP: 165.51.95.249)

lutte contre la maladie du ministère et s'appropriait certains domaines qui devraient revenir à d'autres départements [3]. Cela dit, la coordination et la communication entre les parties prenantes se sont nettement améliorées depuis Ebola et la connaissance des rôles des parties prenantes sont des éléments essentiels d'une gestion résiliente [21-24]. En avril 2020, le gouvernement guinéen a signé un décret (décret D/2020/080/PRG/SGG) pour créer un groupe de travail pour le conseiller, le Conseil scientifique de riposte contre la pandémie de la maladie à coronavirus, composé de 17 experts dans différents domaines (épidémiologie, socioanthropologie, économie, laboratoire, pharmacologie, etc.) [25]. Parallèlement, un autre décret désignait l'ANSS comme responsable de la coordination de la réponse [17]. Donc, malgré l'existence de nombreux comités et structures depuis la première épidémie d'Ebola, nous en sommes revenus à une prise de décision très centralisée au niveau de la Présidence, pourtant décriée en début d'épidémie d'Ebola en 2014 [3].

La *diversité* rappelle le besoin des États de pouvoir affronter plusieurs défis sanitaires tout en poursuivant l'offre de services de santé de qualité. La littérature sur les systèmes de santé résilients affirme que les États devraient être en mesure de poursuivre un minimum d'offre de services sanitaires réguliers pendant les épidémies en plus de poursuivre les activités dans les autres secteurs [26-29]. Cela n'a pas été le cas pendant la première épidémie d'Ebola, car tous les efforts ont été centrés sur la riposte. Nos résultats confirment que la poursuite des activités régulières est encore difficile dans le contexte de la COVID-19. La double crise d'Ebola et de COVID-19 qui a sévi en 2021 est un exemple flagrant de l'importance de pouvoir travailler sur plusieurs fronts. Il persiste une difficulté à mobiliser des ressources internes et une dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux. Malgré la hausse des investissements nationaux en santé, le secteur demeure sous-financé et sous la cible d'Abuja de 15 % [30]. Les minces ressources financières peuvent être directement liées aux lacunes en ce qui a trait aux infrastructures sanitaires et autres ressources [31].

Pour sa part, la *conscience* est directement liée à la préparation aux crises et à l'importance de détenir des plans clairs ainsi qu'une bonne connaissance du contexte. Elle suppose également d'avoir des procédures claires pour favoriser une réponse rapide [31, 32]. On observe un avancement significatif à ce sujet puisque les plans développés dans la période post-Ebola ont permis une intervention plus rapide et efficace face à la COVID-19. Par contre, les tensions sociales omniprésentes depuis le début de la pandémie ont eu tendance à perturber l'adhésion de la population aux mesures de santé publique [17].

L'*autorégulation* montre que la rapidité de notification et d'intervention grâce à des équipes, structures et mécanismes spécifiques peut exercer une influence majeure sur les éclosions. Par exemple, la Guinée a été très proactive dans la réponse à la pandémie en imposant rapidement des mesures restrictives. Les innovations développées pendant Ebola comme le microcerclage ont été adaptées pour répondre à la pandémie actuelle [16]. Cette rapidité de réponse a été facilitée par le développement de plans et procédures en amont, mais aussi par la disponibilité de ressources variées.

L'*adaptabilité* démontre comment les leçons apprises et l'expérience acquise lors des épidémies précédentes peuvent renforcer la réponse aux crises futures. L'épidémie d'Ebola a permis aux parties prenantes guinéennes de prendre connaissance des insuffisances du point de vue de la résilience et de mettre en œuvre différentes stratégies pour renforcer le système de santé et le système de réponse aux crises. Aujourd'hui, la Guinée possède des mécanismes de gestion des crises sanitaires plus résilients qui sont testés en temps réel.

Ce tour d'horizon de la gestion des crises sanitaires en Guinée comporte certaines limites. Bien que de nombreuses organisations nationales et internationales aient été rencontrées, il s'agissait d'un échantillonnage raisonné d'experts sélectionnés en fonction des critères d'inclusion spécifiques à l'étude. Dans le cas d'une étude qualitative, le critère de saturation théorique est variable [33], nous avons donc jugé que la taille de l'échantillon fournissait une bonne représentation du phénomène à l'étude. La triangulation des données issues de la collecte post-Ebola a permis de diminuer certaines limites méthodologiques. Considérant que la COVID-19 est en cours et que les écrits concernant la Guinée sont encore peu nombreux, certaines limites quant à la disponibilité et la fiabilité de la documentation peuvent être légitimement exprimées. L'analyse ne permet donc pas de généraliser les résultats et la validité est circonscrite au cas de la Guinée pour la période étudiée. Toutefois, cette étude est pertinente puisqu'elle offre un portrait de la situation actuelle en Guinée et pourrait inspirer d'autres États africains ayant des contextes fragiles à étudier le renforcement de leur résilience après deux années de pandémie de COVID-19.

Conclusion

Étant donné la fragilité ubiquiste de la Guinée, le système de santé n'est toujours pas pleinement résilient. Il est de toute façon impossible d'affirmer qu'un système l'est

entièrement puisque la résilience se mesure par des comparaisons et en mettant en relations des variables [34]. Toutefois, si les gains obtenus pour chacune des caractéristiques de la résilience ont certainement permis d'améliorer la riposte face à la COVID-19, la résurgence d'Ebola en février 2021 et d'autres virus comme Marburg en août 2021 en Guinée suggère aujourd'hui de pousser l'analyse pour mieux évaluer la résilience face à de multiples crises en simultané et de la comparer à un autre État comme la République démocratique du Congo qui a vécu une situation similaire. Une double crise complexifie encore davantage la gestion et implique une fatigue des ressources humaines comme le suggère Adepoju [35], c'est pourquoi le renforcement des cinq caractéristiques de la résilience peut permettre d'améliorer la riposte.

Aucun conflit d'intérêts déclaré

Références

1. Durski KN, Osterholm M, Majumdar SS, Nilles E, Bausch DG, Atun R. Shifting the paradigm: using disease outbreaks to build resilient health systems. BMJ Global Health. 2020;5(5):e002499.
2. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). États de fragilité 2020 [Internet]. OECD; 2021 [Visité le 13/08/2021]. En ligne : https://www.oecd-ilibrary.org/development/etats-de-fragilite-2020_0d344c87-fr/
3. Maltais S. La gestion résiliente des crises sanitaires dans les États fragiles : étude de la crise d'Ebola en Guinée [thèse de doctorat]. Ottawa : Université d'Ottawa; 2019 [Visité le 31/01/2020]. En ligne : http://ruor.uottawa.ca/handle/10393/39855
4. Maltais S, Brière S, Yaya S. Résilience face aux crises sanitaires : un modèle d'analyse pour mieux cerner la complexité de gestion dans les États fragiles. Lien Social et Politiques. 2022;88:132-151. DOI: https://doi.org/10.7202/1090984ar .
5. Boozary AS, Farmer PE, Jha AK. The Ebola outbreak, fragile health systems, and quality as a cure. JAMA. 2014;312(18):1859-60.
6. Kekulé AS. Learning from Ebola Virus: How to Prevent Future Epidemics. Viruses. 2015;7(7):3789-97.
7. Kruk ME, Myers M, Varpilah ST, Dahn BT. What is a resilient health system? Lessons from Ebola. The Lancet. 2015;385(9980):1910-2.
8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ebola (Ebola Virus Disease) [Internet]. 2016 [Visité le 24/04/2016]. En ligne : http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/case-counts.html.
9. Calnan M, Gadsby EW, Kondé MK, Diallo A, Rossman JS. The Response to and impact of the Ebola epidemic: Towards an agenda for interdisciplinary research. Int J Health Policy Manag. 2017;7(5):402-11.
10. Therrien MC. Stratégies de résilience et infrastructures essentielles. Telescope. 2010;16(2):154-71.
11. Fortin A, Bi JVB, Soulimane A. Les enseignements de l'épidémie d'Ebola pour une meilleure préparation aux urgences. Sante Publique. 2017;29(4):465-75.
12. Organisation mondiale de la santé (OMS). Rapport du groupe d'experts chargé de l'évaluation intérimaire de la riposte à Ebola [Internet]. 2015 [Visité le 24/04/2016]. En ligne : http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-panel-report-fr.pdf?ua=1
13. Système des Nations unies en Guinée. Capacités nationales en matière de réduction des risques et de gestion des catastrophes en Guinée. Rapport d'évaluation. 2016.
14. Benton B, Handuleh J, Harris K, Maruthappu M, Patel P, Godman B, *et al.* Health in fragile states. Med Confl Surviv. 2014;30(1):19-27.
15. Haimes YY. On the definition of resilience in systems. Risk Analysis. 2009;29(4):498-501.
16. Bonnet E, Bodson O, Le Marcis F, Faye A, Sambieni E, Foumet F, *et al.* The COVID-19 pandemic in francophone West Africa: From the first cases to responses in seven countries. Research Square. 2020;14.
17. Delamou A, Sidibé S, Camara A, Traoré MS, Touré A, Van Damme W. Tackling the COVID-19 pandemic in West Africa: Have we learned from Ebola in Guinea? Prev Med Rep. 2020;20:101206.
18. Sow A, Criel B. COVID-19 en Guinée : mobilisation de la première ligne de soins au Sud et au Nord ! [Internet]. Blog BMJ GLobal Health. 2020 [Visité le 26/09/2022]. En ligne : https://blogs.bmj.com/bmjgh/2020/05/12/covid-19-en-guinee-mobilisation-de-la-premiere-ligne-de-soins-au-sud-et-au-nord/.
19. Camara I, Touré A, Camara A, Marcis FL, Bangoura ST, Kpamou C, *et al.* Preparing for the COVID-19 pandemic response in a country emerging from an Ebola Epidemic: Assessment of health workers knowledge, attitudes and practices on coronavirus (COVID-19) in Guinea. JPHE. 2020;12(4):318-28.
20. Aborode AT, Tsagkaris C, Jain S, Ahmad S, Essar MY, Fajemisin EA, *et al.* Ebola Outbreak amid COVID-19 in the Republic of Guinea: Priorities for Achieving Control. Am J Trop Med Hyg. 2021;104(6):1966-9.
21. Chandes J, Paché G. La coordination des chaînes logistiques multi-acteurs dans un context humanitaire : quels cadres conceptuels pour améliorer l'action ? Logistique & Management. 2006;14(1):33-42.
22. Comfort L, Ko K, Zagorecki A. Coordination in rapidly evolving disaster response systems. Am Behav Sci. 2004;48(3):295-313.
23. Grange M. Ebola : le droit international au soutien de la lutte contre une épidémie transfrontière. Annuaire français de droit international. 2014;60(1):685-706.
24. Stephenson MJ. Making humanitarian relief networks more effective: operational coordination, trust and sense making. Disasters. 2005;29(4):337-50.
25. Rajan D, Koch K, Rohrer K, Bajnoczki C, Socha A, Voss M, *et al.* Governance of the Covid-19 response: a call for more inclusive and transparent decision-making. BMJ Glob Health. 2020;5(5):e002655.
26. Almedom AM. Resilience to disasters: A paradigm shift from vulnerability to strength. Afr Health Sci. 2008;8(Suppl 1):S1-4.
27. Kieny MP, Dovlo D. Beyond Ebola: a new agenda for resilient health systems. The Lancet. 2015;385(9963):91-2.
28. Kieny M-P, Evans DB, Schmets G, Kadandale S. Health-system resilience: reflections on the Ebola crisis in western Africa. Bulletin of the World Health Organization. déc 2014;92(12):850-850.
29. Therrien MC, Normandin JM, Denis JL. Bridging complexity theory and resilience to develop surge capacity in health systems. J Health Organ Manag. 2017;31(1):96-109.

Téléchargé le 30/09/2022 sur cairn.info (IP: 165.51.95.220)

30. ONU, Commission de l'Union africaine. Note d'information : 10 ans après « L'engagement d'Abuja » d'allouer 15 % des budgets nationaux à la santé. New York : Nations unies ; 2011.
31. Matua GA, Wal DMV der, Locsin RC, Matua GA, Wal DMV der, Locsin RC. Ebola hemorrhagic fever outbreaks: strategies for effective epidemic management, containment and control. Braz J Infect Dis. 2015;19(3):308-13.
32. Roca A, Afolabi MO, Saidu Y, Kampmann B. Ebola: A holistic approach is required to achieve effective management and control. J Allergy Clin Immunol. 2015;135(4):856-67.
33. Savoie-Zajc L. Comment peut-on construire un échantillonnage scientifiquement valide ? Rech Qual. 2006;99-111.
34. Chandler D. Beyond neoliberalism: resilience, the new art of governing complexity. Resilience. 2014;2(1):47-63.
35. Adepoju P. Ebola and COVID-19 in DR Congo and Guinea. The Lancet Infectious Diseases. avr 2021;21(4):461.
36. Ling EJ, Larson E, Macauley RJ, Kodl Y, VanDeBogert B, Baawo J, *et al.* Beyond the crisis: did the Ebola epidemic improve resilience of Liberia's health system? Health Policy Plan. 2017; 32(Suppl_3):S40-7.

S.F.S.P. | Téléchargé le 15/10/2025 sur https://sfsp.cairn.info (IP: 165.51.95.249)